Introducción a la Unidad 1

Vea este video en la versión online de la clase

Unidad 1: “Síncope”. Elaborada por Catalina Baeza, Urgencióloga Clínica UC San Carlos de Apoquindo.

En esta unidad revisaremos los siguientes artículos:

1 | Definición y fisiopatología del síncope.
2 | Enfrentamiento del paciente con síncope en el Servicio de Urgencia.

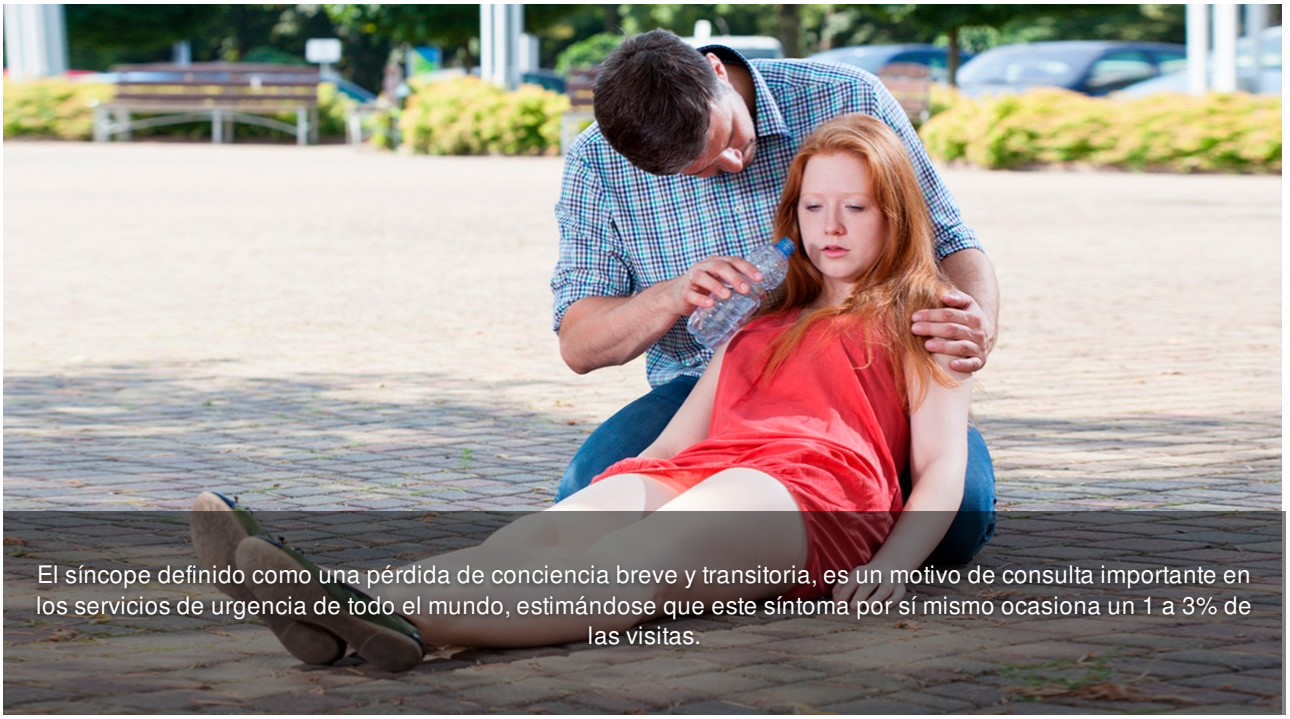
Objetivos de la Unidad

Los objetivos de esta unidad son:

- Definir síncope como síntoma cardinal y lograr distinguirlo de otros motivos de consulta que se presentan en el Servicio de Urgencia.
- Conocer la fisiopatología involucrada que provoca el continuo presíncope-síncope-muerte súbita.

- Evaluar al paciente que se presenta por un síncope al Servicio de Urgencia.
- Estratificar el riesgo y disposición del paciente que consulta por síncope al Servicio de Urgencia.

Definición y fisiopatología del síncope

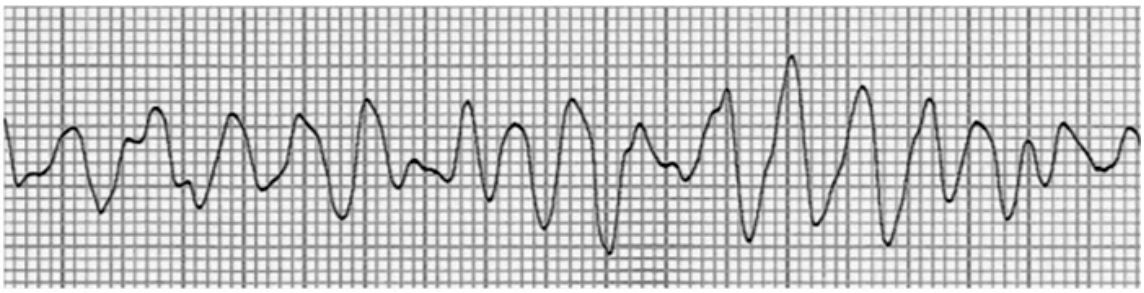


El síncope definido como una pérdida de conciencia breve y transitoria, es un motivo de consulta importante en los servicios de urgencia de todo el mundo, estimándose que este síntoma por sí mismo ocasiona un 1 a 3% de las visitas.

Caso Clínico

Paciente masculino 32 años. Consulta a Servicio de Urgencia por presentar episodio de compromiso de conciencia súbito, de segundos de duración, con recuperación completa.
Ingresa a Servicio de Urgencias. Su evaluación primaria y signos vitales al ingreso son completamente normales.

El examen físico tampoco revela hallazgos significativos. Se realiza un electrocardiograma en el que observa ritmo sinusal con bloqueo incompleto de rama derecha y elevación del ST en precordiales derechas. Mientras espera en su box, súbitamente presenta compromiso de conciencia y al monitor se observa:



A los 30 segundos, se realiza cardioversión eléctrica y retorna ritmo sinusal. Es ingresado al hospital para monitorización y estudio electrofisiológico: es diagnosticado definitivamente como Síndrome de Brugada. Se

instala un desfibrilador implantable y mantiene controles periódicos con cardiología hace 4 años, en buenas condiciones.

Magnitud del problema

Entre un 20 a 50% de la población podría presentar algún episodio sincopal durante la vida, aunque solo la mitad de ellos consultarán por esta causa[1].

Aquellos que efectivamente acuden a la urgencia, tienen mayor probabilidad de estar presentando una patología emergente, a diferencia de aquellos que se atienden ambulatoriamente. Afortunadamente, lo más frecuente es que el cuadro sea ocasionado por alguna condición benigna.

Los episodios sincopales neuromediados y ortostáticos no se asocian a aumento de morbimortalidad cardiovascular y se presentan predominantemente en pacientes adolecentes y jóvenes adultos.

Sin embargo, en algunos casos el síncope se deberá a patologías graves, de alta mortalidad. Los pacientes con patología cardiovascular preexistente y síncope por cualquier causa presentan un riesgo aumentado de morir a corto y largo plazo.

Pacientes con antecedentes cardiológicos, 1 año posterior a un síncope presentan casi un 8% de probabilidad de morir y la mitad de las veces esto será por una causa cardiovascular.

La edad, insuficiencia cardíaca y enfermedad coronaria son predictores de mortalidad en pacientes con síncope.

Es por esta razón que cada paciente que atendamos por este motivo en la Urgencia requiere nuestra evaluación sistematizada y completa con el fin de identificar prontamente los casos potencialmente graves, estudiarlos y manejarlos adecuadamente.

Definición

Síncope se define como:

- Pérdida de conciencia súbita, breve y transitoria.
- Incapacidad de mantener el tono postural.
- Recuperación espontánea.
- Recuperación ad integrum.

Podemos entonces precisar que:

La pérdida de conciencia debe ser súbita, breve y transitoria

Síncope no es estar durmiendo, tampoco un estado post ictal y menos aún el resultado de una intoxicación.

Recuperación espontánea

Por lo tanto, no es hipoglicemia (porque la pérdida de conciencia revierte tras administrar glucosa).

Recuperación ad integrum

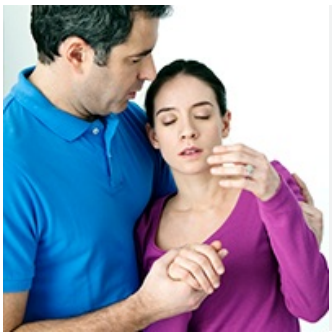
El paciente, posterior al síncope, vuelve completamente a su estado basal. El paciente no presentará focalidad neurológica posterior ni otra alteración sostenida de su estado mental (como por ejemplo en el post ictal).

Fisiopatología

Un episodio sincopal es causado por la hipoperfusión global de la corteza de ambos hemisferios cerebrales o por hipoperfusión focal del sistema reticular activante, usualmente aguda.

Hipervínculo externo: *SNC: sustancia reticular* VER

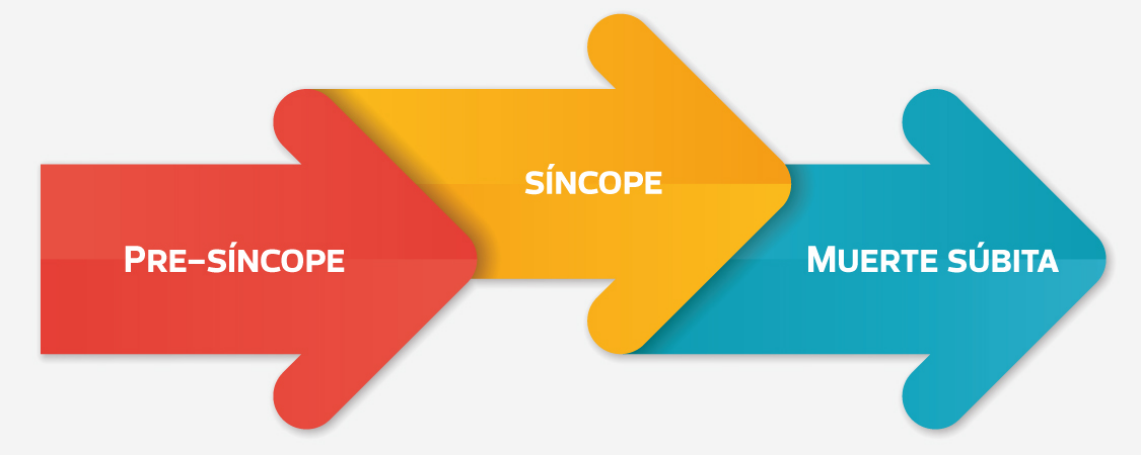
Cualquiera de los componentes involucrados en la perfusión global y del Sistema Nervioso Central (SNC) al verse afectadas podrían provocar el síntoma (recordemos los componentes que condicionan la perfusión tisular: Gasto cardíaco, Resistencia vascular Sistémica, etc). Específicamente, la disminución del flujo cerebral puede ser ocasionada por hipotensión sistémica o por disminución del flujo regional (vasocontricción cerebral).



Para hacernos una idea, podemos estimar que un grado de hipoperfusión cerebral mayor a un 35% puede provocar inconciencia. Sin embargo, un nivel de hipoperfusión menos severa puede causar lipotimia o “presíncope” (sensación de debilidad generalizada o desvanecimiento), síntoma por el cual también muchos pacientes consultan a las urgencias (“casi me desmayé”, “sentí que me iba a desmayar…”).

El otro extremo del cuadro es cuando la disminución del flujo cerebral es mantenida constantemente, causando finalmente un paro cardiorrespiratorio (Muerte Súbita).

Por lo tanto, dado que **el pre-síncope, el síncope y la muerte súbita comparten una vía fisiopatológica común, debemos enfrentar los episodios sincopales y presincopales de la misma manera, como si fueran el mismo motivo de consulta,** para evitar así que algunos de ellos lleguen a la muerte súbita.



En el siguiente video profundizaremos sobre la fisiopatología del Síncope.

Vea este video en la versión online de la clase

Clasificación

Podemos clasificar los síncopes según las causas que lo provocan. La mayoría de los pacientes presentarán síncopes de causas benignas, pero aproximadamente **un 10 % de los pacientes serán de origen cardiovascular** y estos se relacionan a **mayor mortalidad**[2].

Existen varias formas de clasificar los síncopes según su origen, en este artículo los agruparemos dentro de 4 grandes grupos, para ayudarnos principalmente en nuestro diagnóstico operacional.

Es preciso señalar que un episodio sincopal puntual puede ser multifactorial y, por lo tanto, imposible de ser encasillado en uno solo de estos grupos.

1. Síncope Neuromediado

Es el más frecuente, abarca aproximadamente el 60% de los cuadros y se debe a un inapropiado control nervioso que lleva a vasodilatación generalizada, con o sin bradicardia.

Dentro de este grupo podemos encontrar específicamente las siguientes subcategorías:

a **Síncope vasovagal:** cuando nos enfrentamos a un estímulo estresante, la respuesta normal es mantener elevado el tono simpático. Sin embargo, en estos pacientes esta respuesta está abolida e incluso se activa intensamente el tono parasimpático.

Se da principalmente en pacientes jóvenes, sin cardiopatía estructural y en general tiene excelente

pronóstico.

Puede ser gatillado por dolor, Valsalva , fiebre o instrumentalización. Los síntomas son vagos y subjetivos. Por lo general vienen precedidos de un marcado pródromo (sudoración, visión borrosa, mareos) y estos síntomas siguen presentes una vez que se recupera la conciencia. No debería ser un diagnóstico definitivo en la Urgencia, excepto en casos recurrentes, con episodios alejados en el tiempo y descartándose todo el resto de las condiciones de alto riesgo.

b **Síncope Situacional**: cuando estos episodios se presentan recurrentemente en relación a una situación particular como: dolor, post ejercicio, miccional, defecación, al exponerse a sangre o agujas, etc.

2. Síncope Ortostático

La hipotensión ortostática se define como la caída > 20 mmHg en la PAS o una PAS < 90 mmHg; o una caída en la PAD > 10 mmHg o una PAD < 60 mmHg, durante los 3 primeros minutos posterior a ponerse de pie.

Son aproximadamente el 9% de los síncopes. En estos casos, la respuesta autonómica es insuficiente frente a una caída del gasto cardíaco, ya sea producto de una disminución del volumen intravascular (deshidratación, hemorragia) o una disminución del sistema autonómico simpático (primaria o secundaria, como por ejemplo, debido a medicamentos beta bloqueadores o a su deterioro en los pacientes con diabetes mellitus).

A diferencia del síncope vasovagal, usualmente hay taquicardia e intentos de subir la presión arterial, pero estos mecanismos fallan.

En general son benignos dado que no involucran alteraciones estructurales cardíacas, pero las etiologías que los pueden provocar sí podrían ser graves.

Ejemplo: shock hemorrágico por embarazo ectópico, aneurisma de la aorta abdominal roto, hemorragia digestiva, etc.

Recordar que: A pesar de que la etiología de un síncope puede ser benigna, algunas veces pueden requerir mayor estudio e incluso hospitalización por las lesiones secundarias al síncope, ejemplo: TEC (traumatismo encéfalo craneano) o por motivos sociales (ejemplo: riesgo de caídas).

3. Síncope Cardiovascular

Corresponde al 10-30% de los síncopes. Son en proporción minoritarios pero incluyen a los pacientes con riesgo vital. Se provocan por arritmias o alteraciones estructurales cardíacas que disminuyen bruscamente o interrumpen el gasto cardíaco, no pudiendo mantenerse la perfusión cerebral.

Es por eso que, a diferencia de los síncopes vasovagales, muchas veces **no presentan síntomas pródromicos**. Muy frecuentemente hay una anormalidad estructural preexistente como primera causa o contribuyente.

Síncope de origen cardíaco:	
1.Arritmias	
2.Isquemia (< 3%)	
3.Lesiones estructurales	Valvulopatías
	Miocardiopatías
4. TEP (Tromboembolismo pulmonar)	

Las arritmias son las causas más frecuentes y pueden ser letales (taquicardia ventricular). Generalmente hay un sustrato anatómico del corazón que provoca la alteración eléctrica. Debemos buscar dirigidamente bloqueos aurículoventriculares, enfermedad del nodo AV (Aurículo ventricular) y enfermedades estructurales como valvulopatías y miocardiopatías.

La isquemia es una causa mucho menos frecuente de síncope y muy rara vez ocurre sin asociarse a dolor torácico. Cuando provoca síncope, se relaciona a importante aumento de la mortalidad y riesgo de muerte súbita. Si además hay signos de falla cardíaca, estos números empeoran.

4. Síncopes Secundarios

Estos son secundarios a enfermedades particulares, las que en su forma de presentación habitual no está el síncope, pero pueden presentarse como tal y ser este el síntoma que los haga consultar a la urgencia. En general el síncope se asocia a otro síntoma que nos puede hacer sospechar cuál es la enfermedad responsable. Para esto debemos evitar anclarnos precozmente a los diagnósticos habituales y abrirnos a estas posibilidades.

Algunos de ellas son:

- Síndrome coronario agudo
- Embarazo ectópico
- Rotura de aneurisma aórtico abdominal
- Hemorragia digestiva alta
- Hemorragia subaracnoidea
- Shock obstructivo
- Tromboembolismo pulmonar masivo
- Neumotórax a tensión
- Tamponamiento cardíaco

En todos estos casos, la clave será asociar el síncope a otro signos cardinal, alertándonos inmediatamente que estamos frente a un paciente de riesgo.

Ejemplos:

- Síncope + dolor torácico → Infarto agudo al miocardio
- Síncope + cefalea → Hemorragia subaracnoidea
- Síncope + dolor abdominal → Aneurisma abdominal roto
- Síncope + disnea → Tromboembolismo pulmonar
- Síncope + dolor abdominal, sangrado genital (mujer) → Embarazo ectópico
- Síncope + hematemesis → Shock hemorrágico (aneurisma aórtico roto, hemorragia digestiva alta)

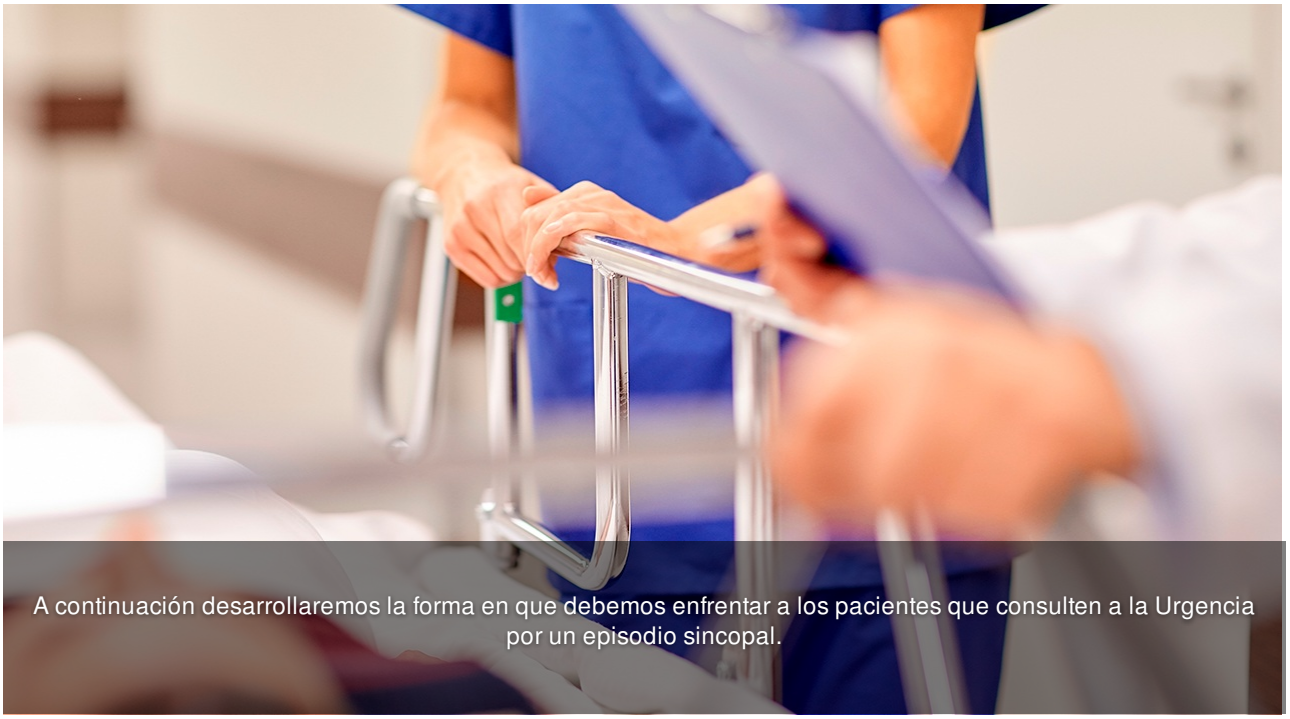
Diagnósticos críticos y emergentes

En cada paciente con síncope, debemos primero enfocarnos en demostrar que el paciente NO tiene:

- Arritmias (Taquicardia ventricular)
- Síndrome Coronario Agudo (SCA)
- Síndrome Aórtico agudo
- Estenosis aórtica severa
- Miocardiopatía hipertrófica
- Tromboembolismo Pulmonar (TEP)/ Tamponamiento
- Hemorragia Subaracnoidea (HSA)
- Shock hemorrágico, hipovolémico

PAS: Presión Arterial Sistólica.
PAD: Presión arterial diastólica.

Enfrentamiento en el Servicio de Urgencia



A continuación desarrollaremos la forma en que debemos enfrentar a los pacientes que consulten a la Urgencia por un episodio sincopal.

Es fundamental:

1. Identificar etiologías que involucren riesgo vital.
2. Evaluar sistemáticamente a cada paciente para intentar determinar la causa del evento.
3. Realizar estratificación de riesgo: Estimar la posibilidad de eventos adversos en el paciente con síncope de causa no precisada y definir según esto su destino: estudio hospitalizado versus alta.

El objetivo primordial de la evaluación del paciente con síncope en el Servicio de Urgencia es identificar la patología tiempo dependiente.

Numerosa evidencia apoya que con una buena anamnesis y examen físico podemos distinguir la mayoría de las etiologías de un síncope[1].

¿Fue realmente un síncope?

Lo primero que debemos hacer cuando recibimos al paciente es identificar: **¿Fue realmente lo que ocurrió un síncope?**

Será crucial en primera instancia diferenciar si se trata efectivamente de un síncope y no otro síntoma cardinal, como por ejemplo compromiso de conciencia o convulsión.

Dentro de la evaluación primaria, rápidamente debemos descartar hipoglicemia, hipoxia y otros cuadros que no cumplan los criterios de la definición de síncope.

Así, evaluaremos por un track de trabajo distinto a los pacientes que presentan imitadores de un síncope, es decir, aquellos cuadros que resultan en compromiso de conciencia pero secundarios a otros mecanismos distintos a la hipoperfusión cerebral transitoria. Los más usuales son:

Convulsión

La historia y examen físico tienen buena Sensibilidad y Especificidad (95%) para diferenciar un episodio sincopal versus uno comicial[2].

En un episodio convulsivo, a diferencia del síncope, existe una activación generalizada neuronal, por lo que después de la convulsión característicamente existe un período “post-ictal” en que el paciente persiste con algún nivel de compromiso de conciencia y puede demorar entre 20 y 30 minutos en recuperar completamente su basal.

En el síncope en cambio, la recuperación es *ad-integrum* y rápida, generalmente en segundos.

La mordedura de lengua es un elemento del examen físico sumamente útil a la hora de diferenciar estos dos cuadros. La mordedura de lengua lateral que se produce durante una convulsión tónico clónica es un signo altamente específico[3].

Los testigos de un síncope muchas veces aseguran que el paciente “convulsionó”, describiendo movimientos involuntarios de las extremidades. De hecho, un gran porcentaje de los síncopes pueden presentarse efectivamente con mioclonías e incluso tonicidad y desviación de la mirada durante los primeros segundos del episodio, esto debido a que fisiopatológicamente el cuadro se debe a un bajo flujo cerebral. Pero en una convulsión los movimientos involuntarios son de mayor duración, repetitivos y estereotipados.

Favorecen el diagnóstico de síncope

- Despertar ad integrum
- Precedido por náuseas y vómitos
- Posterior a mantener una postura por tiempo prolongado
- Historia enfermedad cardiovascular

Favorecen diagnóstico de convulsión

- Post ictal
- Aura
- Episodios convulsivos previos
- Mordedura de lengua: S 24% y E 99% (si es lateral: E 100%)
- Duración del compromiso de conciencia > 5 min
- Fase tónica y luego clónica rítmica
- Desviación de la cabeza o posturas aberrantes

Hipoglicemia

En el síncope, por definición se recupera la conciencia espontáneamente. El compromiso de conciencia por hipoglicemia es más prolongado y requiere de una intervención (administración de glucosa) para la recuperación del paciente.

Otros cuadros neurológicos

- **Hemorragia subaracnoidea:** Al sangrar, puede producir compromiso de conciencia autolimitado (si es extensa y compromete ambos hemisferios cerebrales o si aumenta transitoriamente la PIC).
- **Accidente cerebrovascular transitorio (territorio vertebrobasilar):** Es muy infrecuente que un Accidente isquémico transitorio (TIA) pueda confundirse con un síncope, pero si específicamente la isquemia se produce en la sustancia reticular activante o, más extensamente, en tronco, puede ocurrir compromiso de conciencia; si hay reperfusión temprana habrá además recuperación rápida. Sin embargo, generalmente estos cuadros se acompañan de síntomas neurológicos de fosa posterior (vértigo, disartria, diplopía, disfagia).
- Los **hematomas subdurales** pueden simular también un síncope cuando son extensos. Pueden producir cuadros de compromiso de conciencia intermitente, sobre todo en adultos mayores, y eso podría confundirse con un episodio sincopal.

Causas psiquiátricas

Siempre debe ser un diagnóstico de exclusión, aunque conozcamos el antecedente de psiquiátrico del paciente.

Hay que recordar que los pacientes con patologías psiquiátricas utilizan muchos fármacos que pueden predisponer a padecer síncopes secundarios a arritmias por QT largo, ortostatismo, bradicardia, entre otros.

Además, lo más probable es que un paciente psiquiátrico simule o tenga síntomas conversivos similares a síntomas de patologías que efectivamente padece; en estos casos los síntomas orgánicos y los psiquiátricos muchas veces se presentarán de forma intercalada y habrá que descartar con el estudio apropiado las enfermedades graves cada vez que consulte.

Historia clínica

Para afinar el diagnóstico es fundamental hacer bien una historia clínica.

¿Quién es el paciente?

Edad: pacientes jóvenes presentan frecuentemente síncopes de causas benignas.

Sin embargo, ¿es la edad un factor independiente de riesgo en un síncope o solo si se asocia comorbilidades?

Este es un tema muy controversial, no se ha logrado delimitar un punto de corte en cuanto a edad que se asocie a riesgo por sí mismo.

Especialmente en pacientes jóvenes, no podemos dejar de indagar sobre **historia familiar de muerte súbita**, lo que nos guiará hacia una causa cardiovascular del síncope y, por ende, a algo de mayor gravedad.

En los pacientes adultos mayores, pacientes con historia de cardiopatía coronaria o de alteración estructural cardíaca o pacientes con historia familiar de muerte súbita, siempre debemos pensar en solicitar mayor estudio u hospitalizar para su monitorización.

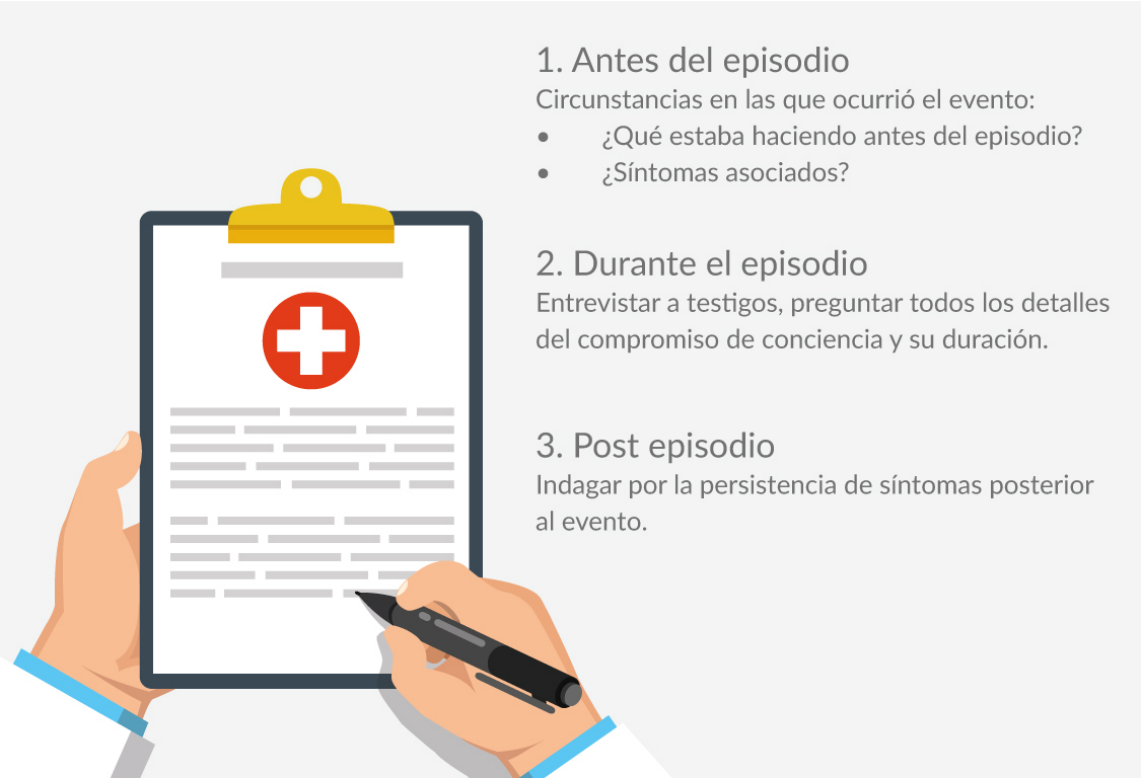
Hay que recordar que debemos revisar extensamente la lista de medicamentos y drogas que el paciente pueda estar utilizando, incluyendo drogas sin prescripción médica, de abuso y homeopáticas.

- Medicamentos Beta bloqueadores
- Calcio (Ca) antagonistas
- Vasodilatadores (nitratos, hidralazina, iECA, etc.)
- Diuréticos
- AntiHTA centrales (clonidina, metildopa)
- Antiarrítmicos (↑ QT)
- Antidepresivos, antipsicóticos
- Agentes QT
- Aintinflamatorios no esteroidales (AINEs)
- Bromocriptina
- Anticonvulsivantes (fenitoína, carbamazepina)
- Antiparkinsonianos
- Benzodiazepina (BDZ)
- Barbitúricos
- Inhibidos de la monoaminoaxidasa (iMAO)
- Opioides
- Antihistamínicos
- Inhibidores colinesterasa
- Drogas de abuso

Por supuesto, debemos recopilar antecedentes quirúrgicos incluyendo la instalación de marcapaso o defibrilador implantable.

En mujeres en edad fértil, no tenemos que olvidar interrogar sobre la fecha de la última menstruación, ya que un embarazo ectópico roto está dentro de los diagnósticos diferenciales, incluso un embarazo normal podría dar síntomas presincopales.

Sobre el episodio mismo sincopal, es importante detallar con precisión lo ocurrido **antes, durante y después del síncope.**



Antes del episodio

¿Qué estaba haciendo antes del episodio?

- Posición.
- Actividad y situación: (ejercicio, tos, defecación, risa, emoción). Un síncope DURANTE el ejercicio es un signo de alarma (sospecha miocardiopatía hipertrófica).
- Cambios de posición
- Prodromo: palpitaciones, inestabilidad o mareo. La ausencia de un prodromo es sugerente de Taquicardia Ventricular (TV).

Síntomas asociados

Es clave para la identificación de patologías de riesgo vital.

- Síncope y cefalea: Hemorragia subaracnoídea.
- Síncope y dolor torácico: Síndrome coronario agudo, Síndrome aórtico agudo.
- Síncope y disnea: Tromboembolismo pulmonar, neumotórax espontáneo.
- Síncope y dolor abdominal: Aneurisma aórtico roto, embarazo ectópico roto.

Durante el episodio

El paciente no recordará el suceso, por lo que la entrevista al testigo será tan importante como la entrevista al propio paciente para obtener la anamnesis de primera fuente.

Debemos preguntar por todos los detalles del compromiso de conciencia, su duración, el “mecanismo de caída” (con protección o sin protección), características de los movimientos estereotipados (inicio unilateral, desviación de la mirada, patrón respiratorio), etc.

Recordemos que hasta un 75% de los pacientes con síncope pueden presentar mioclonías durante el evento debido a la efectiva hipoperfusión cerebral. Por esta misma razón, puede verse incontinencia urinaria y/o fecal tanto en un síncope como en una convulsión.

Después del Episodio

Lo más importante será indagar por la persistencia de síntomas posterior al evento, y en la presencia o ausencia de un compromiso de conciencia prolongado, que nos haga pensar en un período post-ictal, desviando nuestro diagnóstico hacia convulsiones.

Al examen físico

Signos vitales

Los signos vitales son claves en la evaluación de todo paciente que presenta un síncope. Cualquier alteración en alguno de ellos nos debe sugerir que estamos frente a un paciente de riesgo.

Deben ser registrados siempre:

- La presión arterial
- Frecuencia cardíaca y respiratoria
- Saturación de oxígeno
- Temperatura.

La caída de la presión arterial minutos inmediatos después de ponerse de pie sugieren síncope mediado por hipotensión ortostática.

Ortostatismo
Caída > 20 mmHg PAS o PAS < 90 mmHg
Caída PAD > 10 mmHg o PAD <60 mmHg
A los 3 primeros minutos posterior a ponerse de pie.

Sin embargo, esta definición clásica según los signos vitales no es sensible ni específica para el diagnóstico de un síncope por hipotensión ortostática. Se ha visto que ocurre en casi un 40% de los adultos asintomáticos mayores de 70 años, en 16% de los sujetos sanos de cualquier edad y en un tercio de los pacientes con síncope por cualquier causa, por lo que es frecuente como hallazgo en los signos vitales.

Por otro lado, este es un diagnóstico de exclusión y nunca debemos diagnosticarlo en pacientes de riesgo moderado-alto. Además, algunos pacientes pueden presentar síntomas de hipotensión ortostática de forma concomitante y no ser esta la causa de su episodio sincopal actual.

Cabeza y cuello

- Cabeza y cuello: Mordedura de lengua.
- Soplos carotideos o irradiación soplo cardíaco al cuello (E. Aórtica).
- Yugulares.

Examen cardiovascular

Es muy importante tomarse el tiempo para realizar un exhaustivo examen cardiopulmonar y vascular en estos pacientes.

Cualquier signo que sugiera cardiopatía estructural o falla cardíaca identificará de inmediato a un paciente de riesgo, que probablemente deberá ser monitorizado y estudiado en una unidad acorde.

Para estos pacientes, un próximo episodio sincopal puede ser finalmente muerte súbita.

Debemos buscar dirigidamente signos de patología valvular, obstrucción del tracto de salida y falla cardíaca derecha. Además, debemos pesquisar signos de falla cardíaca, porque en estos pacientes un síncope tiene en general peor pronóstico.

Debemos fijarnos y describir también los pulsos periféricos, el llene capilar y las yugulares.

No olvidemos la semiología clásica:

Miocardiopatía Hipertrófica

Choque de la punta desplazado e intenso
Soplo sistólico de eyección (30-40%) en el 2-3º espacio intercostal borde esternal

Estenosis Aórtica

Soplo eyectivo (en forma de rombo, de preferencia mesosistólico) en el foco aórtico. Frecuentemente irradiado al cuello, en algunas ocasiones también se ausculta irradiado hacia la punta del corazón.
Personas expertas pueden oír además la apertura de la válvula aórtica .
Presión de Pulso ↓

Abdominal

Cicatrices que puedan evidenciar, por ejemplo, una cirugía aortica. Indispensable realizar el tacto rectal frente a la sospecha de síncope secundario a ortostatismo por hemorragia.

Examen neurológico

Como vimos con anterioridad, muy rara vez un síncope tiene origen neurológico central, pero es fundamental realizar un examen neurológico acabado en estos pacientes: revisaremos el examen mental, pares craneanos, evaluación motora y sensitiva, reflejos osteotendíneos, examen cerebeloso y signos meníngeos.

Nos orientará a descartar además que el paciente no haya presentado otro síntoma imitador de síncope (convulsión, hipoglicemia, etc).

Exposición: signos de trauma

Al sufrir el síncope, el paciente cae y puede presentar trauma craneal, faciales, cervical o de las extremidades (muñeca, cadera), según el mecanismo de caída. Cualquiera de estas lesiones puede tener por sí misma indicación de estudio y hospitalización. Algunas series reportan que hasta un 30% de los síncopes vasovagales sufren lesiones asociadas y el 10% requieren hospitalización por éstas.

Muchos de los pacientes que sufren síncope son adultos mayores, por lo tanto, con gran frecuencia encontraremos usuarios de antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes. Deberemos determinar si requerirán una imagen de cerebro para descartar hemorragia intracerebral secundaria al TEC (y no como parte del estudio etiológico del síncope). Si el trauma lo amerita, inmovilizaremos el cuello hasta descartar una lesión cervical con las imágenes adecuadas, pero de regla no es necesario inmovilizar con collar cervical a todos los pacientes.

Las injurias asociadas al síncope no se relacionan con la gravedad de la etiología.

Dentro de la “exposición”, también recordemos fijarnos en cicatrices quirúrgicas torácicas y abdominales que nos hagan sospechar cirugías cardíacas o de la aorta, así como también en la presencia de marcapasos.

El Electrocardiograma (ECG)

La recomendación es realizar un electrocardiograma (ECG) en cada uno de los pacientes que se presenten con síncope o presíncope en el servicio de urgencia. A pesar de que su rendimiento es mucho menor que la historia y el examen físico en la búsqueda de etiología, es un examen que prácticamente siempre está disponible, no tiene efectos adversos y es de bajo costo.

Por otra parte, aunque su rendimiento diagnóstico es limitado (entre un 2 a 9%), sí tiene un alto valor predictivo negativo y un ECG anormal en un episodio sincopal se asocia a arritmias (OR 8.1) y muerte (OR 3.2)[4]. Esto hace que en determinados casos sea determinante para la disposición y la terapia definitiva del paciente que consulta por síncope o presíncope al servicio de urgencia.

Por supuesto, un ECG “normal” no descarta una patología cardíaca o enfermedad grave como causa del síncope, pero sí disminuye de forma significativa su probabilidad.

Será fundamental que conozcamos y busquemos dirigidamente signos en el trazado que sugieran las siguientes patologías:

- Infarto Agudo al miocardio
- Bloqueos:
  Bloqueo auriculoventricular
  Bloqueo trifasicular
- Arritmias:
  Bradiarritmia
  Taquiarritmia
- Síndromes de QT:
  corto
  largo
- Síndromes de preexitación (PR corto)
- Síndrome de Brugada
- Miocardiopatía hipertrófica
- Displasia arrtimogénica del ventrículo derecho
- Derrame pericárdico
- Tromboembolismo pulmonar

A continuación puedes revisar algunos ejemplos en el siguiente archivo descargable.

Hipervínculo externo: *Electrocardiograma* VER

Sobre el ECG y su utilidad en el diagnóstico etiológico del síncope profundizaremos y practicaremos durante la clase final de este curso.

Laboratorio y otros test diagnósticos

No son recomendables de rutina, salvo que la buena historia y examen físico indiquen lo contrario.

En ese contexto, podrían ser de utilidad:

- Hematocrito
- Electrolitos plasmáticos (especialmente Potasio)
- Test de embarazo en orina o BHCG
- Biomarcadores (troponina)
- Scanner de cerebro

Niveles elevados de prolactina durante las primeras horas posterior a un episodio transitorio de compromiso de conciencia podrían identificar una convulsión y distinguirla de un síncope. Sin embargo, la aplicabilidad de este examen en el escenario de urgencia es cuestionable y la gran mayoría de los casos la respuesta estará dada por la clínica, siendo un recurso innecesario.

Reglas predictivas clínicas

A pesar de que realicemos una buena anamnesis y examen físico, solo en la minoría de los casos llegaremos con seguridad al diagnostico etiológico del síncope. Esto nos lleva inevitablemente a plantearnos la pregunta:

¿Es seguro dar de alta a este paciente? ¿O debo hospitalizarlo para monitorización y estudio?

La decisión es difícil y se han estudiado diferentes reglas predictivas clínicas para ayudarnos a tomar conductas seguras y costo-efectivas para nuestro paciente.

La idea es que estos criterios nos ayuden a estimar con parámetros objetivos, cuál es el riesgo que nuestro paciente presente un desenlace negativo en un determinado período de tiempo.

Ninguna de las reglas que nombraremos a continuación tiene la suficiente sensibilidad ni especificidad, como tampoco, adecuada aplicabilidad en nuestro contexto: no pueden reemplazar el criterio clínico de médico de urgencia, pero conocerlas puede ayudarnos a tomar decisiones con más herramientas.

San Francisco Syncope Rule (SFSR)[5]

La regla más utilizada es la Regla de Síncope de San Francisco. La presencia de cualquiera de los siguientes positiviza el score:

C - Historia de insuficiencia cardíaca
H - Hematocrito <30%
E - ECG alterado
S – Disnea
S – Sistólica <90 mmHg

Una revisión sistemática el 2011 reportó una sensibilidad de 87% (IC 95%, 79-93%) y una especificidad de 52% (IC 95%, 43-62%) para evento adverso a corto plazo, lo que significa que una paciente con síncope de origen no precisado tiene un 2% de probabilidad de presentar un desenlace fatal[6].

Otras reglas predictivas clínicas:

- Observatorio Epidemiológico sulla Sincope del Lazio (OESIL)[7]
- Risk stratification of Syncope in the Emergency Department (ROSE)[8]
- Evaluation of guidelines in Syncope Study Score (EGSYS)[9]

Además, una reciente publicación propone un nuevo score para evaluar el riesgo de eventos adversos a partir de un estudio prospectiva realizado en la urgencia, por lo que podemos ver que el tema está aun en discusión[10].

Disposición

A estas alturas del artículo, podemos vislumbrar que no hay examen de laboratorio ni imagen ni regla predictiva clínica que logre darnos la respuesta para estratificar con seguridad el riesgo de nuestro paciente que presentó un síncope[11].

La historia, la evaluación primaria y el examen físico más detallado serán la clave para obtener gran cantidad de información que nos ayudará a acercarnos al diagnóstico etiológico y con esto identificar a los pacientes eventualmente graves.

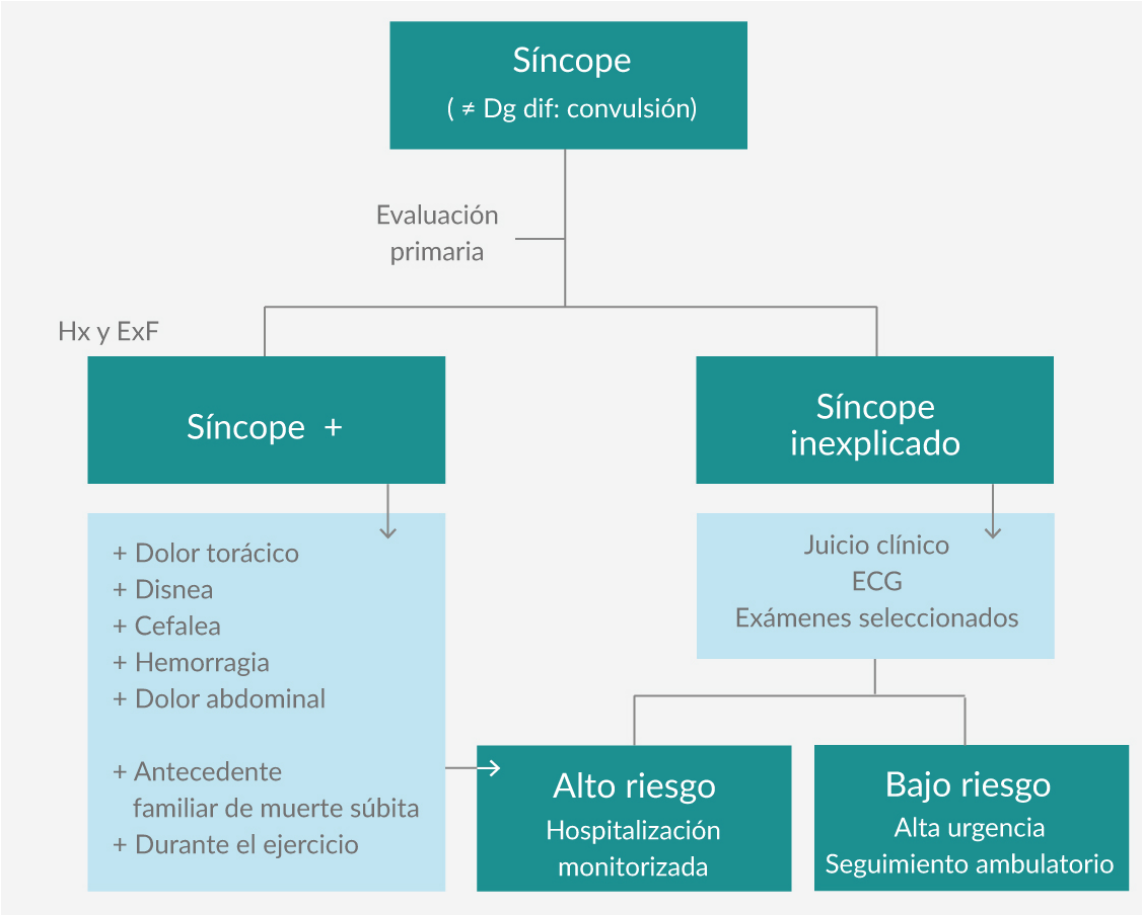
Con la información que recopilemos durante la atención podemos considerar para continuar un manejo ambulatorio a los pacientes que:

1. No tengan antecedentes de riesgo como:
   - Antecedente de patología cardiovascular
   - Antecedentes familiar de muerte súbita
   - Edad (adulto mayor)
2. No presenten "banderas rojas" (síntomas de riesgo) como:
   - Síncope "asociado a…" (síncope + cefalea, síncope + dolor abdominal, síncope + hemorragia, etc.)
   - Ausencia de Pródromo
   - Palpitaciones previas al episodio
   - Síncope durante el ejercicio[12]
   - Hematocrito < 30%. En general una persona con un hematocrito menor a 30% tiene otros signos clínicos que nos hacen sospecharlo, por lo que podríamos prescindir de tomar este examen a los pacientes que NO están pálidos, taquicárdicos, taquipneicos, hipotensos o con ortostatismo.
3. Presenten signos vitales normales y examen físico aceptable, sin hallazgos relevantes (especialmente sin signos de falla cardíaca ni patología cardíaca estructural).
4. Su Electrocardiograma (ECG) sea normal.
5. Sin lesiones graves asociadas a la caída (sin riesgo social).

Si todos estos criterios se cumplen, el paciente probablemente tiene un bajo riesgo de resultados adversos al alta. Lo más recomendable es que luego del alta tenga un seguimiento precoz con cardiología, en general, con ecocardiograma transtorácico y un holter de arritmia.

Las cifras varían mucho entre diferentes centros hospitalarios, pero se estima que casi la mitad de los pacientes que consultan por síncope son admitidos en el hospital para monitorización y estudio. Los adultos mayores concentran un 80% de estas hospitalizaciones. La mortalidad al mes del episodio depende de la causa del síncope y las comorbilidades, pudiendo ser hasta de un 5%.

Algoritmo operacional sugerido



Puntos Principales

- Dar de alta a los pacientes que se podrán estudiar diferidamente sin por esto exponerlos a riesgo vital.
- Hospitalizar para estudio a los pacientes que se van a beneficiar de tener un diagnóstico, aquellos en los que el síncope es manifestación de una enfermedad asociada a riesgo de muerte por causa cardiovascular.
- No olvidar las lesiones asociadas a la caída por síncope, aunque este haya sido de origen benigno.

Bibliografía Unidad 1

- Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice, 9th Edition
- D'Ascenzo F, Biondi-Zoccai G, Reed MJ, et al. Incidence, etiology and predictors of adverse outcomes in 43,315 patients presenting to the Emergency Department with syncope: An international meta-analysis. Int J Cardiol 2013; 167(1): 57-62.
- Ann Intern Med. 1997; 126 (12) Int J Cardol 2008; 127 (1) Am J Med 001; 111 (3)
- J Am Coll Cardiol. 2002.
- Arch Intern Med 1995.
- Risk stratification of patients with syncope. Ann Emerg Med 1997; 29: 459-66.
- Quinn J1, McDermott D, Stiell I, Kohn M, Wells G.Prospective validation of the San Francisco Syncope Rule to predict patients with serious outcomes.Ann Emerg Med. 2006 May;47(5):448-54. Epub 2006 Jan 18.
- Saccilotto RT, Nickel CH, Bucher HC, Steyerberg EW, Bingisser R, Koller MT. San Francisco Syncope Rule to predict short-term serious outcomes: a systematic review. CMAJ : Canadian Medical Association Journal. 2011;183(15):e1116-e1126. doi:10.1503/cmaj.101326.) LINK
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3193123/
Colivicchi F, Ammirati F, Melina D, et al. Development and prospective validation of a risk stratification system for patients with syncope in the emergency department: the OESIL risk score. Eur Heart J 2003;24:811–9
https://academic.oup.com/eurheartj/article/24/9/811/2733957
- Risk stratification of Syncope in the Emergency Department (ROSE) Referencia como hipervinculo o profundización. Reed MJ, Newby DE, Coull AJ, et al. Reed MJ, Newby DE, Coull AJ, et al. The ROSE (risk stratification of syncope in the emergency department) study. J Am Coll Cardiol 2010;55:713–21
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2658233/
Validation of EGSYS Score in Prediction of Cardiogenic Syncope
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4663288/
- Bozorgi A1, Hosseini K, Jalali A, Tajdini M. A New Feasible Syncope Risk Score Appropriate for Emergency Department: A Prospective Cohort Study. Crit Pathw Cardiol. 2018 Sep;17(3):151-154. doi: 10.1097/HPC.0000000000000146. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/30044256/
- Costantino G, Casazza G, Reed M, et al. Syncope risk stratification tools vs clinical judgment: an individual patient data meta-analysis. Am J Med. 2014 Nov;127(11):1126.e13-25. doi: 10.1016/j.amjmed.2014.05.022. Epub 2014 May 23. Review.
Pathophysiology of Noncardiac Syncope in Athletes https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29605837